コンテンツ設計 ｜ 統合まとめ

歯科医院向け 健康経営サービス

① 設計思想

本サービスは「神経報酬差（体験価値差）」を軸に設計する。各プランは脳内の異なる回路を刺激し、段階的に行動変容を促す。

プラン	松（無料）	竹（7 万円/月）	梅（18 万円/月）
脳の目的	扁桃体解除（安心）	前頭前野活性（気づき）	側坐核活性（行動強制）
神経報酬	安心ドーパミン	報酬予測誤差	競争的ドーパミン
狙い	気づき・接触	改善実感	定着・仕組み化
ROI	未来への種まき	離職半減	採用コスト回避

設計原則：価格差は「頻度」と「強制力」で作る。 松＝自発、竹＝半強制、梅＝実行構造

---

② 価格設計（アンカリング設計）

元の 5 万・15 万は「わかりやすい」が、利益最大化設計ではない。推奨価格は以下の通り。

プラン	月額	価格設定の根拠	役割
松	無料	母集団を最大化	リード獲得装置
竹	7 万円	ユニット償却以下 → 「投資枠」に入る	利益の柱（粗利約 60%）
梅	18 万円	年 216 万円 ＝ 衛生士 1 人の離職コストと一致	価値の象徴・ブランド

※ 5 万は安すぎて本気感が弱く、15 万は心理的分水嶺。7 万・18 万は「中途半端に見えて強い」価格帯。

---

③ コンテンツ設計（各プラン共通）

松（無料）｜接触・気づきモデル

目的：扁桃体解除・心理的安全性の確保・信頼形成。「何も売らない」設計。

◆**バイタルデント公式 LINE（ダイエット診断／睡眠診断／自己肯定感診断／姿勢チェック）**

- **健**康コラム配信（食事・睡眠・脳科学）
- エクササイズ動画閲覧（腰痛・肩こり・睡眠・疲労回復・脳トレ・副交感神経回復）
- 健康経営簡易チェック（セルフ）

◆【オプション】出張整体体験 **初回割引（有料導線への入口）**

▶️ 実質原価：約 3,000〜5,000 円/月（LINE 按分＋動画制作固定費＋運用時間）

竹（7 万円/月）｜改善設計＋月 1 整体モデル

目的：経営接続・改善実感を作る。松の内容に加えて以下を提供。

- 月 1 回 院長面談＆フィードバック（60 分）
- 健康経営診断（ヒアリング実施）・分析レポート
- 月 1 回 脳科学ミニセミナー（60 分）
- 月 1 回 出張整体 or リラク（2 時間枠：1 人 15 分×8 人）

▶️ テーマ例：疲労と生産性 ／ 睡眠と医療事故 ／ 自己肯定感と離職
▶️ 院長のメリット：「何をやるべきか分かる」「体が楽になった」即時効果
▶️ 合計原価：約 4.5 万円　粗利：約 2.5 万円（約 35〜60%）

梅（18 万円/月）｜神経回復仕組み化モデル

目的：行動変容の実装・継続改善・定着。竹の内容に加えて以下を提供。

- 週 1 回 出張整体 or リラク（受動回復）
- 月 1〜2 回 出張エクササイズ（能動回復）
- 月 1〜2 回 脳科学セミナー・勉強会（90 分）
- スタッフ簡易コンディションレポート
- 四半期健康スコアレポート・改善レポート提出
- 離職予兆アラート分析
- 表彰制度設計支援（教育重視型オプション）

▶️ 設計思想：整体＝受動回復、エクササイズ＝能動回復、診断＝可視化、面談＝意思決定　すべてを統合
▶️ 合計原価：約 9〜13 万円（整体外注含む）　粗利：約 28〜50%
⚠️ 整体週 1 はコスト大。月 2 回・外注 15,000 円交渉・グループ形式で粗利 50%近くまで回復可能

---

④ 差別化の本質

機能	松	竹	梅
情報	受動	受動＋整理	体系化
診断	簡易	本診断	継続分析
院長関与	無	月 1	月 1（深堀）
教育	無	月 1	月 2 以上
運動	動画のみ	月 1 整体	月 2〜週 1
整体	体験導線	月 1	月 2〜4

---

⑤ 利益設計（20 医院導入モデル）

想定転換率

- 松 → 竹：40%
- 松 → 梅：20%
- 松のみ：40%

ケース A：バランス型（竹 10 院・梅 5 院）

	竹（10 院）	梅（5 院）	合計
月売上	70 万円	90 万円	160 万円
月原価	30 万円	35 万円	65 万円
月粗利	40 万円	55 万円	95 万円
年間粗利	—	—	約 1,140 万円

▶️ 3 年モデル：20 医院固定化で年間粗利 1,000 万超。ここに新規が積み上がる。
▶️ 経営上の本音：利益を作るのは「竹」。梅はブランド＋事例作り。松は母集団形成。

---

⑥ 経営者への ROI 提示

歯科医院モデル前提

- スタッフ 8 名（DH3 名）、衛生士年収 400 万円、採用コスト実質 200 万円、離職率 25%

トータルインパクト試算

改善項目	年間効果
離職 1 人防止	▲200 万円 損失回避
採用費削減	▲50〜150 万円
残業削減（10h×8 名×12 ヶ月）	▲約 192 万円（時給 2,000 円換算）
欠勤率 10%改善	▲約 20 万円
自費率 1%向上（年商 1 億）	＋100 万円
合計潜在インパクト	▲約 420 万円以上

梅プラン年間：216 万円　→　ROI 約 2 倍
提案トーク：「採用 1 人防げば元が取れます」

---

⑦ プレゼン構造（ニューロマーケティング設計）

目的：「これは健康の話ではない、経営の根幹の話だ」と院長の脳内フレームを書き換える。

STEP	フェーズ	脳の動き	スライド・トーク例
1	常識破壊	予測誤差発生	離職は給与が原因ではない → 神経疲労が本

			因
2	衝撃の真実	報酬予測誤差	疲れている人は前向きな判断ができない
3	見えない損失	扁桃体刺激	1 人退職 = 200 万円損失（採用費・教育・生産性低下）
4	感情共鳴	オキシトシン	本当は、辞めさせたくなかった → 信頼構築
5	解決策提示	安全挿入	院長の手間ゼロで改善が仕組み化される
6	ベネフィット具体化	ドーパミン	松竹梅を提示。各プランのベネフィットを数字で示す
7	行動誘導	側坐核→行動	採用を頑張り続けますか？辞めない仕組みを作りますか？

---

⑧ クロージングスクリプト（完全版）

構造：恐怖 → 安全 → 未来 → 損失回避 → 小さな Yes

【導入 30 秒】
「先生、率直にお聞きします。衛生士さんが 1 人辞めたとき、実質いくら損失が出るかご存じですか？紹介料・教育ロス・生産性低下を含めると約 200 万円です。」

【常識破壊 30 秒】
多くの医院は給与が原因と思っています。しかし実際は慢性的な神経疲労の蓄積が原因です。辞める前に睡眠不足→自己肯定感低下→集中力低下というサインが出ています。

【損失提示 30 秒】
「もし 3 年で 3 人辞めていたら 600 万円の損失です。これは設備 1 台分以上です。」

【解決策 40 秒】
「私たちは、院長の手間ゼロで現場の状態を可視化し、自動でフィードバックが回り、改善が仕組み化される健康経営の仕組みを提供しています。」

【数字ベネフィット 40 秒】
「離職 1 人防止→200 万円改善、自費率 1%向上→年商 1 億で+100 万円、残業削減→年間約 100 万円圧縮。合計 400 万円以上のインパクトも可能です。」

【クロージング（選択式）】
「まずは無料から始めますか？それとも本気で離職を止めにいきますか？」（×「どうしますか？」は使わない）

【小さな Yes】
「では、今月は無料導入だけ進めましょう。」

---

⑨ 最終事業構造

- 松で母集団 100 医院を形成（松→竹転換率目標 30〜40%）
- 竹・梅で収益化
- 離職改善事例を量産
- 紹介で拡大

キャッチコピー：

「採用を頑張る医院と、辞めない身体を作る医院。どちらが強いと思いますか？」

「これは福利厚生ではありません。医療品質の話です。」